

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS E542 3410499 ALB

WENDELL ALEXANDRE DA ROCHA

IDADE: 49 PESO: 108 ALTURA: 187 PROFISSÃO: Balconista - Farmac.
SINTOMAS: Ronco / Apneia
QUEIXAS: cansado / Torçozelo inchado
MEDICAMENTOS: Alopurinol / litote / clonitrazido / anti-ale-
gico
MÉDICO: Dr. Roberto Bonanomi / Mariana Rosa
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N
EXERCÍCIO FÍSICO: não faz
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: N ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 20:30
HORA QUE DORME: 23:30 HORA QUE ACORDA: 7h - 8h
COCHILLO () SIM ☒ NÃO DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO ^{às vezes} fsm.
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: ^{sim} nasal BANHEIRO: ox
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: ^{gigantesca} CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IV ☒ ++ IAH: 73,2 SPO2: 70%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: - Redução audição
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA q CPAP - 20,5 e hr - 77%
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS Cálculo Renal

30/04 - Avaliação: CPAP Auto BMC + másc Pico XL
24

06/05 P= 7-12 cmH₂O mediana: 7,8 cmH₂O
24 IAH= 1,9 e/h
m. de uso: 7h 47m
fuga: 2,6 l/m Bem adaptado
Natacha

13/05 P= 7-12 cmH₂O fixo 8 cmH₂O
24 IAH= 2,0 e/h
m. de uso: 7h 17m
fuga: 0,6 l/m Bem ~~da~~ adaptado
Natacha

27/05 P= 8,0 14d.
24 IAH= 2,0
m. de uso: 6h 11m
fuga= 3,6. Jua

22/06 P= 8,0 cmH₂O
24 IAH= 0,8 e/h
m. de uso: 7h Jua

31/07/24 P=8 cmH₂O

IAH=1,0 e/h

m de uso: 6 h 58'

fuqg: 1,4 e/m

Bem adaptada
Oriento sobre horários
de dormir.

Natasha

10/10/24 P=8 cmH₂O

IAH=1,0 e/h

m de uso: 5 h 15'

Relata não consegue dormir
mais cedo

Apresentando crise renal

Natasha

15/01/25 P=8 cmH₂O

IAH=0,6 e/h

m de uso: 6 h 38'

de 30 dias uso 16

crise de urinite alérgica
esta em tratamento

09/04/2025

P=8 cmH₂O

IAH=1,0 e/h

m uso=6 h 30'

fuqg=1,1 e/m

Natasha

uso Baian / 30d

unike

Auto 5 a 8 cmH₂O

* hora fixador *

Silvia

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: WENDELL ALEXANDRE DA ROXA			
Sexo: M	Idade: 48 anos	Peso: 107 Kg	Altura: 1.87 m
IMC: 30.6	Data do Exame: 07/11/2023	Exame: 13009_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:43:08 PM horas e encerrado às 4:21:51 AM horas, com latência para o sono de 6 minutos e latência para o sono REM de 284 minutos. O tempo total de sono foi de 328.0 minutos, com eficiência do sono de 96.8%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.5%	Até 5%
Estágio 2	85.1%	45 - 55%
Estágio 3	6.6%	> 15%
Sono REM	7.9%	20 - 25%
Eficiência do sono	96.8%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 5 minutos ocorreram **456 despertares (índice de 83.4 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 72 bpm, a maior de 89 bpm e a menor de 60 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 400 eventos respiratórios, sendo 0 central, 400 obstrutivos e 0 misto. Sendo 265 apnéias, 135 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 73.2/hora**, sendo 48.5 apnéia/hora e 24.7 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 29.7 e a duração máxima de 75.3.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 83.1/hora, sendo 83.1 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **96%**, sendo a **saturação média de 92%**, a **maior de 99%** e a **mínima de 70%**, permanecendo 53.9 minutos (15.9%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 1.3 minutos (0.4%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 403 dessaturações. Índice de dessaturações: 73.7/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 83.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 73.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200

Nome: WENDELL ALEXANDRE DA ROCHA

Data de Nascimento: 2-5-1975

IMC: 30,88

Sexo: Masculino

Data do exame: 10-01-2024

Peso: 108 kg

Altura: 1,87 m

Médico: ROBERTO A. C. BONANOMI

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 10-01-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 533,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 165,5 e 147,0 minutos. O tempo total de sono foi de 357,0 min, eficiência de 67,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,8%; estágio N2: 56,4%; estágio N3: 20,4%; sono REM: 21,3%. O índice de despertares foi de 13,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 20,5/hora, sendo 45 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 77 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 77%, permanecendo 2,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 50 - 79 bpm e NREM de 46 - 86 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (3), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. aumento do número de despertares breves;
5. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (30,8/hora);
6. registro de ronco durante o sono.

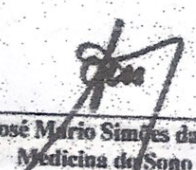
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157



Receita Médica

Paciente: WENDELL ALEXANDRE DA ROCHA

Dt. Atendimento: 19/04/2024

Anestesista
Bucamaxilo Facial
Cirurgia Ap. Digestivo
Cirurgia Geral

ENCAMINHO PACIENTE PARA USO DE CPAP

IND- SAOS

Cirurgia Bariátrica
Cirurgia Vascular
Cirurgião Endovascular
Cirurgião Plástico
Clínica Médica
Clínica de Ortopedia
Clínica de Vacinas
Dermatologia
Endocrinologia
Exames Oftalmológico
Gastroenterologia
Ginecologia e Obstetrícia
Neurocirurgia
Neuroclínico
Oftalmologista
Ortopedia Geral
Ortopedista de Coluna
Otorrino
Pediatra
Proctologia
Psiquiatria
Pneumologista
Urologia
Vascular Clínico

Dra. Mariana Gonçalves Garcia Rosa
(CRM 184015)